INFORME DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 (MMPI-2)

1. Ficha de identificación

Evaluado	Ejemplo ficticio de contraste	**Documento de identidad**	DEMO-001
Fecha de nacimiento	15 de octubre de 1980	**Edad en la aplicación**	46
Sexo normativo	Mujer	**Fecha de aplicación**	3 de noviembre de 2026
Fecha del informe	11 de noviembre de 2026	**Modalidad de aplicación**	Excel
Contexto de evaluación	Clínico	**Evaluador**	Profesional ficticio

2. Motivo y objetivo de la evaluación

Este ejemplo ficticio presenta una evaluación de seguimiento. Su objetivo es integrar el funcionamiento actual con la historia documentada y distinguir los cambios observados de las diferencias entre puntuaciones todavía pendientes de verificación.

3. Antecedentes e historia del caso

La cronología aportada sitúa una aplicación previa en mayo de 2026 y el registro actual en noviembre. Se dispone de cinco puntuaciones T anteriores, pero faltan la confirmación del sexo normativo y la verificación de la misma clave y fuente de corrección. Esta información permite describir ambos registros con sus límites.

Tabla 1. Cronología documentada y estado de verificación

Fecha	Fuente	Hecho	Verificación
2026	Registro ficticio	Inicio del seguimiento	Documentado

4. Técnica, fuentes y control de calidad

Instrumento de autoinforme de 567 ítems. Referencia normativa seleccionada: Estados Unidos · Minnesota.

Las puntuaciones T se interpretan frente al grupo de referencia. T = 50 es el centro de la escala. En este informe, los rangos descriptivos son Bajo (<=39), Habitual (40–55), Promedio superior (56–59), Alto (60–69) y Muy alto (>=70). Los indicadores de validez conservan sus propios criterios.

5. Examen mental y observación conductual

No consta

6. Validez y estilo de respuesta

Tabla 2. Escalas de validez · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T
VRIN	Inconsistencia de respuestas variables	7	—	46	Habitual
TRIN	Inconsistencia de respuestas verdadero	11	—	65V	Alto
F	Infrecuencia	13	—	82	Muy alto
Fb	Infrecuencia posterior	16	—	85	Muy alto
Fp	Infrecuencia psicopatológica	3	—	65	Alto
L	Mentira	5	—	57	Promedio superior
K	Corrección	19	—	59	Promedio superior
S	Autopresentación superlativa	25	—	49	Habitual

Omisiones registradas: 0. Índice F - K (PD): -6.

Lectura del protocolo: interpretable con cautela.

Los indicadores de validez describen aspectos diferentes de las respuestas. El valor actual de VRIN es compatible con respuestas coherentes; el registro anterior presenta una puntuación publicada mayor, cuya equivalencia normativa sigue pendiente de confirmar. La dirección V de TRIN identifica la orientación hacia respuestas Verdadero; su significado se interpreta junto con el conjunto del protocolo.

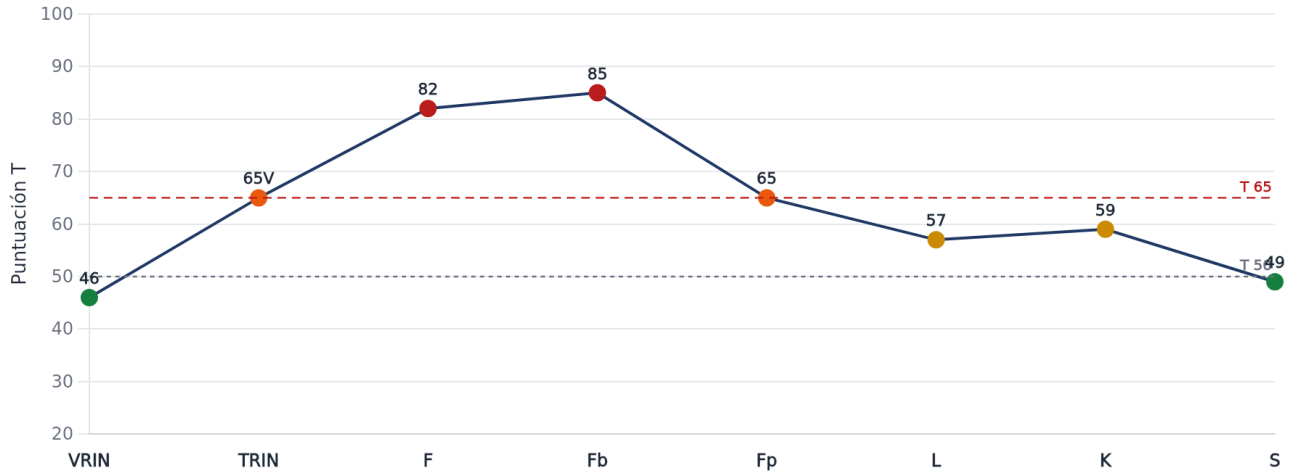


Figura 1. Perfil de escalas de validez.

Hay contenidos que requieren indagación clínica directa de seguridad. Documente vigencia, intención, medios y apoyos.

7. Escalas clínicas básicas

Tabla 3. Escalas clínicas básicas · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T
Hs	Hipocondría	17	27	80	Muy alto
D	Depresión	27	—	64	Alto
Hy	Histeria de conversión	37	—	84	Muy alto
Pd	Desviación psicopática	20	28	63	Alto
Mf	Masculinidad–feminidad	29	—	67	Alto
Pa	Paranoia	15	—	67	Alto
Pt	Psicastenia	20	39	72	Muy alto
Sc	Esquizofrenia	29	48	84	Muy alto
Ma	Hipomanía	25	29	76	Muy alto
Si	Introversión social	27	—	50	Habitual

Las puntuaciones clínicas describen lo que la persona comunica sobre su funcionamiento actual. Su relación con las dificultades cotidianas requiere contrastar el autoinforme con los antecedentes, la entrevista y las fuentes disponibles. El perfil por sí solo no establece un diagnóstico ni una causa de los síntomas.

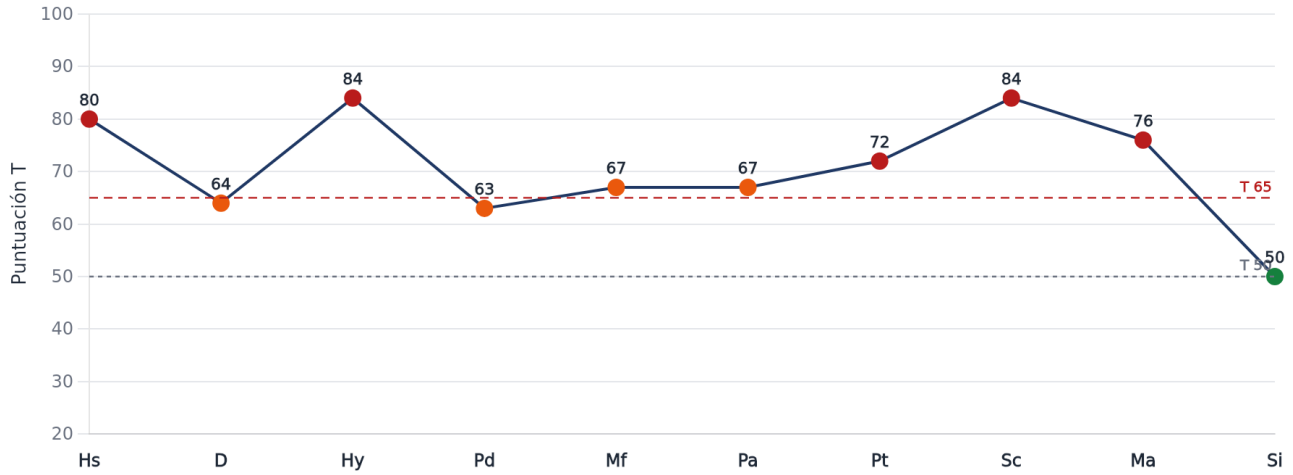


Figura 2. Perfil de escalas clínicas básicas.

8. Escalas de contenido

Tabla 4. Escalas de contenido · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T
ANX	Ansiedad	7	—	51	Habitual
FRS	Miedos	8	—	53	Habitual
OBS	Obsesividad	10	—	**63**	**Alto**
DEP	Depresión (contenido)	10	—	58	Promedio superior
HEA	Preocupaciones por la salud	20	—	**77**	**Muy alto**
BIZ	Pensamiento extravagante	7	—	**67**	**Alto**
ANG	Enojo	10	—	**64**	**Alto**
CYN	Cinismo	11	—	53	Habitual
ASP	Prácticas antisociales	9	—	56	Promedio superior
TPA	Comportamiento tipo A	9	—	53	Habitual
LSE	Baja autoestima	13	—	**68**	**Alto**
SOD	Malestar social	9	—	52	Habitual
FAM	Problemas familiares	9	—	57	Promedio superior
WRK	Interferencia laboral	15	—	**61**	**Alto**
TRT	Indicadores negativos de tratamiento	9	—	59	Promedio superior

Las escalas de contenido complementan la descripción de las dificultades autoinformadas. Su lectura se vincula con el motivo de consulta y con las situaciones de la historia que estén documentadas, sin atribuir a una puntuación aislada una conducta que no haya sido observada.

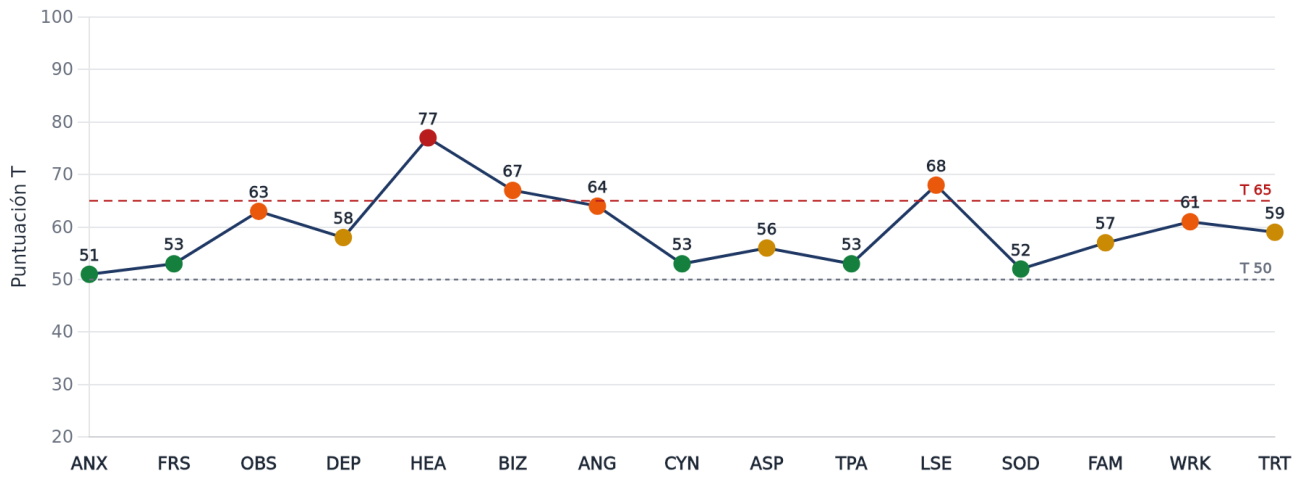


Figura 3. Perfil de escalas de contenido.

9. Escalas suplementarias y PSY-5

Tabla 5. Escalas suplementarias · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T
A	Ansiedad (Welsh)	14	—	53	Habitual
R	Represión	21	—	**62**	**Alto**
Es	Fuerza del yo	22	—	**<=30**	**Bajo**
MAC-R	Alcoholismo de MacAndrew revisada	23	—	**61**	**Alto**
AAS	Reconocimiento de adicción	5	—	**67**	**Alto**
APS	Potencial de adicción	21	—	44	Habitual
MDS	Malestar marital	5	—	59	Promedio superior
Ho	Hostilidad	22	—	56	Promedio superior
O-H	Hostilidad sobrecontrolada	13	—	48	Habitual
Do	Dominancia	17	—	53	Habitual
Re	Responsabilidad social	16	—	**35**	**Bajo**
Mt	Desajuste profesional	19	—	**60**	**Alto**
GM	Rol de género masculino	25	—	44	Habitual
GF	Rol de género femenino	23	—	40	Habitual
PK	Estrés postraumático (Keane)	17	—	**63**	**Alto**

Es: <=30 corresponde al límite inferior de reporte de la referencia estadounidense. La figura sitúa el resultado en T 30 y conserva el signo <=. La puntuación se clasifica en rango Bajo.

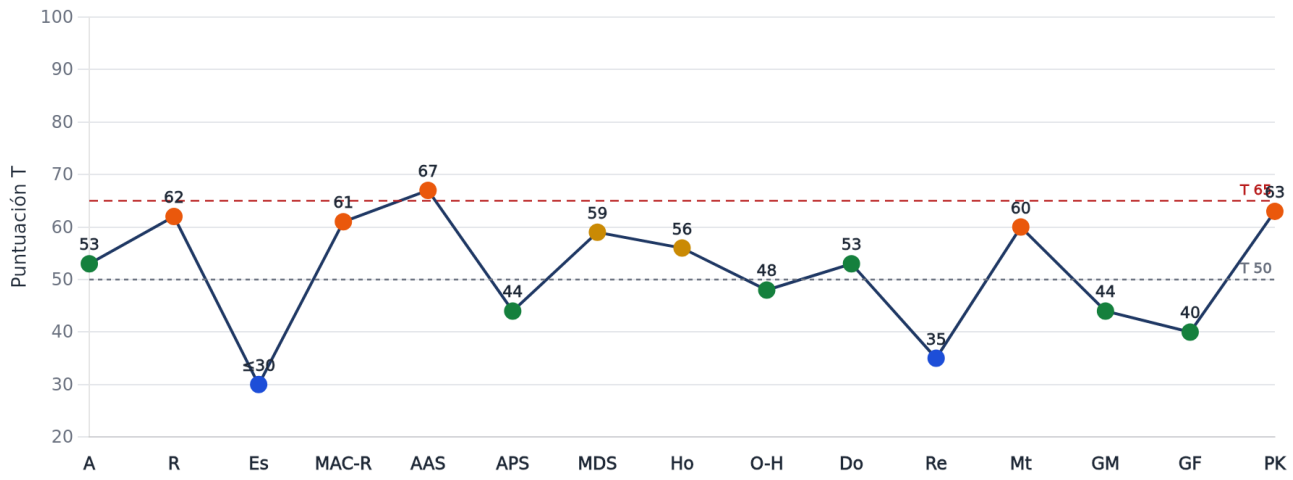


Figura 4. Perfil de escalas suplementarias. Es: <=30.

Personalidad PSY-5

Tabla 6. Dimensiones PSY-5 · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T
AGGR	Agresividad	9	—	57	Promedio superior
PSYC	Psicoticismo	2	—	46	Habitual
DISC	Falta de control	15	—	**63**	**Alto**
NEGE	Emocionalidad negativa	11	—	49	Habitual
INTR	Introversión/Baja emocionalidad positiva	12	—	53	Habitual

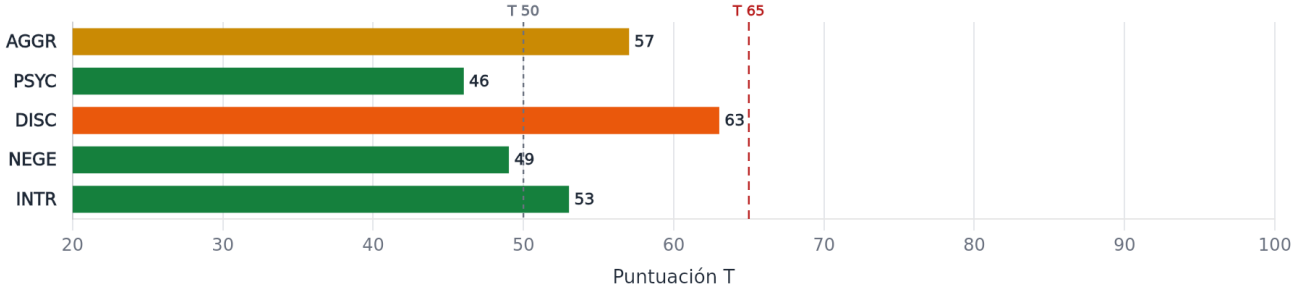


Figura 5. Perfil de dimensiones psy-5.

Las escalas suplementarias y PSY-5 amplían la descripción del estilo personal y de los recursos percibidos. El resultado bajo de Es expresa una percepción reducida de los propios recursos frente al malestar; no permite concluir por sí solo que la persona carezca de habilidades o apoyos efectivos.

10. Subescalas Harris-Lingoes

Tabla 7. Subescalas Harris-Lingoes y de Introversión social · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T
D1	Depresión subjetiva	16	—	**70**	**Muy alto**
D2	Retardo psicomotor	7	—	57	Promedio superior
D3	Disfunción física	8	—	**85**	**Muy alto**
D4	Torpeza mental	7	—	**70**	**Muy alto**
D5	Rumiación	4	—	58	Promedio superior
Hy1	Negación de ansiedad social	4	—	51	Habitual
Hy2	Necesidad de afecto	10	—	**63**	**Alto**
Hy3	Lasitud-malestar	11	—	**83**	**Muy alto**
Hy4	Quejas somáticas	7	—	**65**	**Alto**
Hy5	Inhibición de la agresión	3	—	46	Habitual
Pd1	Discordia familiar	6	—	**74**	**Muy alto**
Pd2	Problemas con la autoridad	2	—	46	Habitual
Pd3	Imperturbabilidad social	5	—	58	Promedio superior
Pd4	Alienación social	3	—	44	Habitual
Pd5	Autoalienación	4	—	53	Habitual
Pa1	Ideas persecutorias	3	—	57	Promedio superior
Pa2	Hipersensibilidad	4	—	59	Promedio superior
Pa3	Ingenuidad	5	—	50	Habitual
Sc1	Alienación social	6	—	**61**	**Alto**
Sc2	Alienación emocional	5	—	**86**	**Muy alto**
Sc3	Falta de dominio cognitivo del yo	4	—	**67**	**Alto**
Sc4	Falta de dominio conativo del yo	5	—	**65**	**Alto**
Sc5	Falta de inhibición	2	—	53	Habitual
Sc6	Experiencias sensoriales extrañas	10	—	**86**	**Muy alto**
Ma1	Amoralidad	4	—	**70**	**Muy alto**
Ma2	Aceleración psicomotora	6	—	55	Habitual
Ma3	Imperturbabilidad	5	—	**62**	**Alto**
Ma4	Autoenvanecimiento	5	—	**62**	**Alto**
Si1	Timidez	4	—	46	Habitual
Si2	Evitación social	2	—	47	Habitual
Si3	Alienación de sí y de otros	6	—	52	Habitual

Las subescalas precisan qué componentes contribuyen a las puntuaciones principales. Su interpretación complementa las escalas de referencia y la información del caso, sin convertir cada componente en un diagnóstico independiente.

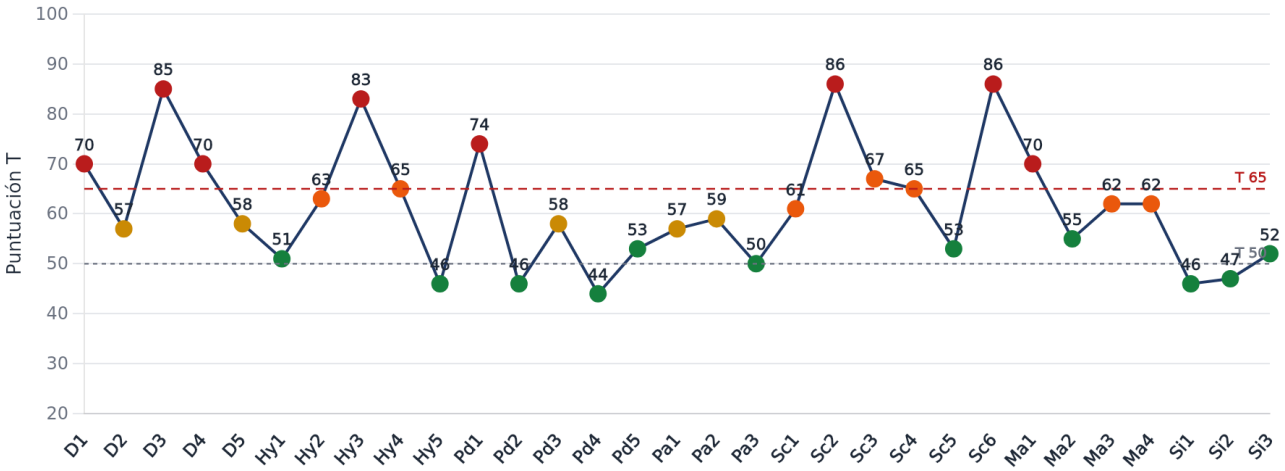


Figura 6. Perfil de subescalas harris-lingoes y de introversión social.

11. Ítems críticos

Tabla 8. Contenidos críticos agrupados por tema

Ítem	Respuesta	Paráfrasis temática
2	F	Ansiedad y activación · Tensión o activación ansiosa.
10	F	Ansiedad y activación · Tensión o activación ansiosa.
28	V	Ansiedad y activación · Tensión o activación ansiosa.
59	V	Ansiedad y activación · Tensión o activación ansiosa.
172	V	Ansiedad y activación · Tensión o activación ansiosa.
223	F	Ansiedad y activación · Tensión o activación ansiosa.
463	V	Ansiedad y activación · Tensión o activación ansiosa.
96	V	Atención y experiencias inusuales · Dificultades percibidas de atención o confusión.
124	V	Atención y experiencias inusuales · Percepción de amenaza o desconfianza.
299	V	Atención y experiencias inusuales · Dificultades percibidas de atención o confusión.
311	V	Atención y experiencias inusuales · Dificultades percibidas de atención o confusión.
314	F	Atención y experiencias inusuales · Percepción de amenaza o desconfianza.
333	V	Atención y experiencias inusuales · Percepción de amenaza o desconfianza.
125	F	Consumo de sustancias · Impacto del consumo de alcohol.
487	V	Consumo de sustancias · Impacto del consumo de alcohol.
489	V	Consumo de sustancias · Impacto del consumo de alcohol.
502	V	Consumo de sustancias · Impacto del consumo de alcohol.
9	F	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
65	V	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
71	V	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
75	F	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.

Ítem	Respuesta	Paráfrasis temática
95	F	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
146	V	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
388	F	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
411	V	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
485	V	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
506	V	Estado de ánimo y seguridad · Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
85	V	Ira y convivencia · Ira o conducta que requiere indagación sobre seguridad interpersonal.
134	V	Ira y convivencia · Ira o conducta que requiere indagación sobre seguridad interpersonal.
389	V	Ira y convivencia · Ira o conducta que requiere indagación sobre seguridad interpersonal.

Los contenidos críticos orientan preguntas de entrevista. La valoración actual del riesgo requiere evaluación directa.

12. Integración clínica

La integración de este ejemplo distingue el estado actual documentado, la historia del seguimiento y las cuestiones pendientes. La comparación de los valores publicados orienta la revisión del expediente; la atribución de mejoría, empeoramiento o efectos de una intervención exige evidencia clínica adicional.

13. Recursos y fortalezas

Los recursos y fortalezas se describen a partir de conductas, apoyos y estrategias documentadas. En este ejemplo no se han aportado observaciones suficientes para identificar fortalezas específicas; una puntuación baja de Es no demuestra su ausencia.

14. Contraste longitudinal

Aplicación anterior del 27 de mayo de 2026.

Fuente anterior: Profesional de prueba.

Tabla 9. Puntuaciones anteriores y actuales documentadas

Escala	Puntuación anterior	T actual	Diferencia T	Lectura
VRIN	76	46	-30	Descenso de 30 puntos T publicados.
TRIN	50	65V	+15	Aumento de 15 puntos T publicados. Orientación actual: Verdadero (V).
Fb	96	85	-11	Descenso de 11 puntos T publicados.
S	55	49	-6	Descenso de 6 puntos T publicados.
Mf	56	67	+11	Aumento de 11 puntos T publicados.

Diferencia T = T actual - T anterior. Es una resta entre valores publicados; por sí sola no demuestra mejoría, deterioro ni cambio fiable.

Comparabilidad normativa no confirmada: sexo normativo anterior sin confirmar; versión, clave y fuente de corrección sin confirmar. Las puntuaciones conservan su referencia original.

En TRIN se restan las magnitudes T y se conservan V/F. El signo de la diferencia no indica por sí solo un cambio de orientación de respuesta.

Contraste de puntuaciones registradas

Se contrastan 5 escalas documentadas del registro anterior con el actual. Se presentan 5 diferencias aritméticas entre las T publicadas.

Validez y estilo de respuesta. VRIN: T anterior 76 y T actual 46 (diferencia -30 T). Respuestas coherentes entre afirmaciones de contenido similar u opuesto, sin inconsistencia relevante. TRIN: T anterior 50 y T actual 65V (diferencia +15 T). Leve predominio de respuestas «Verdadero», sin alcanzar el umbral de inconsistencia relevante. Fb: T anterior 96 y T actual 85 (diferencia -11 T). Respuestas poco frecuentes muy elevadas en la parte final del cuestionario, compatibles con malestar intenso o cambios en la forma de responder. S: T anterior 55 y T actual 49 (diferencia -6 T). Autodescripción positiva dentro de límites habituales, sin idealización marcada de la propia imagen.

Escalas clínicas. Mf: T anterior 56 y T actual 67 (diferencia +11 T). La variación de Mf se refiere a intereses y roles definidos por el instrumento; no es por sí sola un indicador de psicopatología.

Integración contextual del contraste

El registro actual presenta una puntuación menor en VRIN y Fb, mientras TRIN pasa de 50 a 65V. La menor T publicada de VRIN coincide con un resultado actual compatible con respuestas coherentes; Fb continúa elevado pese al descenso numérico. S se sitúa en el rango habitual y la variación de Mf describe intereses y roles, sin constituir un indicador psicopatológico. Las diferencias aritméticas constan en la tabla. La información disponible no permite atribuirlas por sí solas a mejoría clínica ni a efectos de tratamiento.

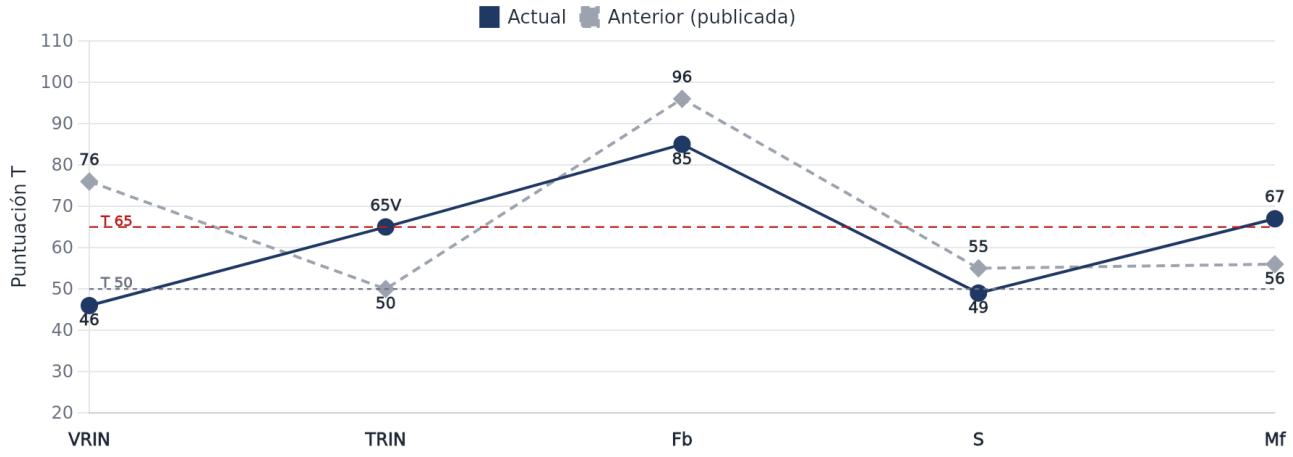


Figura 7. Contraste documental de T publicadas · comparabilidad pendiente.

15. Impresión diagnóstica (tentativa)

No consta entrevista clínica suficiente para formular una impresión diagnóstica tentativa.

16. Limitaciones de la evaluación

La aplicabilidad de la referencia normativa seleccionada depende de la población y de las condiciones de aplicación.

Entrevista clínica suficiente pendiente de documentar.

17. Conclusiones

Este documento es una demostración con datos ficticios. Las puntuaciones, tablas y figuras se generan desde el registro local y el texto contextual se presenta una sola vez por sección.

El contraste longitudinal muestra las cinco puntuaciones previas, sus valores actuales y sus diferencias aritméticas. La falta de confirmación de las referencias anteriores mantiene pendiente la comparabilidad y excluye una conclusión automática de mejoría o deterioro.

La lectura del funcionamiento y de los recursos de afrontamiento requiere integrar el autoinforme con la entrevista y las fuentes documentales. Los aspectos sin evidencia suficiente permanecen explícitamente pendientes.

18. Recomendaciones

- Realizar una valoración directa y estructurada del riesgo suicida (ideación, plan, intentos previos, acceso a medios y factores protectores), dado el reconocimiento de ítems críticos de contenido suicida, y documentar sus resultados.

La revisión clínica del seguimiento debe precisar las fechas de aplicación, recuperar la referencia normativa y la clave del registro anterior, y vincular los hallazgos con el funcionamiento cotidiano. La planificación terapéutica se fundamenta en las necesidades y apoyos confirmados en la entrevista.

Referencias técnicas

- Butcher, J. N. et al. (2001). MMPI-2: Manual for administration, scoring, and interpretation. University of Minnesota Press.
- Referencia de prueba verificada.

Evaluador y firma

Ciudad de prueba · 11 de noviembre de 2026

Profesional ficticio